

Via de administração	Oral
Dose (volume)	1,5ml dependendo do laboratório produtor
Eficácia esperada	70% para todas as formas de diarreia, 86% para as formas graves de diarreia e 80% para hospitalização por rotavírus.
Duração de imunidade	Não há estudos sobre a persistência da imunidade.
Contraindicações	• Imunodeficiência congênita ou adquirida; • Uso de corticoide em dose imunossupressora; • Uso de imunossupressor; • Presença de doença gastrointestinal crônica; • Má formação congênita do trato digestivo; • História prévia de intussuscepção; • Presença de diarreia ou vômito intenso (que levem a desidratação).
Eventos adversos	• Muito comum: irritabilidade; • Comum: perda do apetite, diarreia, vômito, flatulência, dor abdominal, febre, fadiga; • Incomum: constipação, sonolência, distúrbio do sono; • Raros: câibras, dermatite, exantema, rouquidão, rinorreia.
Administração com outras vacinas	• A vacina Rotavírus Humano Vivo Atenuado Oral pode ser administrada concomitantemente ou com qualquer intervalo de tempo entre as demais vacinas monovalentes ou combinadas. • Se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar após a vacinação, não repetir a dose.

Quadro 8. Características gerais das pneumonias por pneumococo

Agente etiológico	Bactéria capsulada <i>Streptococcus pneumoniae</i>
Reservatório	O homem
Modo de transmissão	Direta, pelas vias respiratórias, ou indireta, por objetos contaminados pelas secreções respiratórias.
Período de incubação	Não estimado com precisão, podendo ser de 1 a 3 dias
Suscetibilidade	Universal
Imunidade	• Pela doença; • As vacinas não conjugadas contra o pneumococo conferem imunidade relativa e de curta duração. As vacinas conjugadas conseguem promover imunidade duradoura.

Quadro 8.1. Vacina pneumocócica 10 valente conjugada

Idade recomendada	• 1ª dose aos 2 meses; • 2ª dose aos 4 meses; • Reforço aos 12 meses.	
Conservação	Nível	Temperatura
	Central	+2°C a +8°C
	Regional	+2°C a +8°C
	Local	+2°C a +8°C
	Depende do laboratório produtor: observar o prazo de validade do produto; utilizar imediatamente após a reconstituição ou de acordo com a bula do fabricante.	
Via de administração	Intramuscular	
Dose	0,5ml (ou conforme laboratório produtor)	
Duração da imunidade	Prolongada sempre que a vacina for conjugada.	
Indicações	• Crianças que iniciaram o esquema primário após 4 (quatro) meses de idade, devem completá-lo até 12 meses, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses; administrar o reforço com intervalo mínimo de 60 dias após a última dose; • O reforço deve ser administrado entre 12 meses e 4 (quatro) anos, 11 meses e 29 dias; • Criança entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade com esquema completo de 2 (duas) ou 3 (três) doses, mas sem a dose de reforço, administrar o reforço; • Crianças sem comprovação vacinal, entre 12 meses e 4 (quatro) anos 11 meses e 29 dias, administrar dose única; • Para as crianças de 2 (dois) meses a menores de 5 (cinco) anos de idade, com indicação clínica especial manter esquema de 3 (três) doses e reforço, conforme as indicações do CRIE.	
Contraindicações	Reação alérgica a qualquer um dos componentes da vacina e nas situações de adiamento da vacinação.	
Eventos adversos	• Locais: dor, rubor, edema, enduração no local da aplicação; • Sistêmicos: febre $\geq 38^{\circ}\text{C}$, choro, irritabilidade, sonolência, perda do apetite; • Raros: convulsão febril, rash, reações alérgicas do tipo dermatite atópica, eczema.	